

А.Е. Шалагин,
кандидат юридических наук, доцент
(КЮИ МВД России)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ

В статье рассматриваются понятия «здоровье», «здоровье индивида», «здоровье населения», «преступления против здоровья населения». Отражена классификация преступлений, предусмотренных ст. 228-239 УК РФ. Показана общественная опасность таких преступных деяний. Предложены уголовно-правовые и криминологические меры, направленные на совершенствование института охраны общественного здоровья.

К числу актуальных проблем уголовно-правовой науки относится решение вопроса об охране здоровья населения. Теоретическая и практическая обусловленность данной проблемы вытекает из естественных потребностей общества и государства.

Здоровье населения, являясь приоритетной ценностью, обеспечивает нормальное функционирование всего общественного механизма. Снижение показателей здоровья населения порождает опасность уменьшения величины производимого валового внутреннего продукта страны и национального дохода. Возможность призыва в армию, формирование вооруженных сил полноценным молодым составом резко снижается в условиях, когда уровень здоровья призывников не соответствует жестким требованиям армейской службы [1].

Пьянство, наркомания, проституция, беспризорность существенно влияют на показатели здоровья населения в отрицательную сторону. И наоборот, здоровый и спортивный образ жизни считается одним из важнейших средств сохранения и укрепления здоровья.

В настоящее время преступность, сопряженная с посягательствами на здоровье нации, проникла во все социальные слои, категории и возрастные группы граждан, характерна для всех регионов России. За последние 15 лет в России количество выявленных преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось в три раза. Среди лиц, совершающих такие преступления, доля мужчин и женщин составляет 65% и 35%, две трети – это молодые люди в возрасте 18-29 лет [2].

Проблема борьбы с наркоманией вышла на первый план наряду с опасностью мирового терроризма и экологической катастрофой. Наркобизнес по масштабам своих финансовых операций занимает второе место после торговли оружием. Годовой объем нелегального рынка наркотиков только в России составляет свыше 250 млрд. рублей.

Нарушения законодательства в сфере частной медицинской практики и частной фармацевтической деятельности нередко приводят к причинению вреда здоровью или даже наступлению смерти. Несоблюдение физическими и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, нежелание нести дополнительные материальные затраты, ненадлежащая сертификация пищевой продукции и питьевой воды, халатное отношение местных властей к наведению санитарно-гигиенического порядка на предприятиях торговли и общественного питания, в местах массового нахождения людей, прямое нарушение законодательства со стороны индивидуальных предпринимателей и организаций снижает уровень санитарно-эпидемиологической защиты населения, особенно в

густонаселенных территориальных образованиях, приводит к вспышкам инфекционных заболеваний, нередко заканчивающихся тяжелыми последствиями [3].

Одной из тенденций в криминальном мире выступает резкое увеличение числа преступлений, связанных с производством, хранением, перевозкой либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Массовое проникновение на рынок Российской Федерации товаров иностранного производства низкого качества, достаточно высокая себестоимость товаров местного производителя и постоянно растущая потребность населения в товарной массе позволяют некоторым производителям активно заниматься фальсификацией продуктов и товаров, пользующихся повышенным спросом. При этом в качестве сырья зачастую используются предметы материального мира, изначально представляющие явную опасность для жизни и здоровья людей [4].

В настоящее время остро стоит вопрос противодействия объединениям, посягающим на личность и права граждан. По различным данным, публикуемым в средствах массовой информации, в мире существует около двадцати различных легальных и нелегальных направлений деструктивных сект – христианского, исламского, буддийского, сатанинского и других толков [5]. Кроме того, все чаще заявляют о себе организации политического, военизированного, националистического толка, в деятельности которых просматриваются черты религиозных объединений, посягающих на личность и права граждан.

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье индивида определяется как состояние (процесс) сохранения и развития биологических, физиологических и психологических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни [6].

Здоровье населения представляет собой охраняемую законом обособленную группу общественных отношений, отражающих физическое и психическое благополучие людей, объединенных одной территорией или местностью, условиями проживания, труда и отдыха [7]. Термин «здоровье населения» иногда заменяют на «общественное или популяционное здоровье нации».

В юридической литературе имеются различные подходы к определению преступлений против здоровья населения. Наиболее простое предложено Р.Р. Галиакбаровым, под которыми он понимает «общественно опасные посягательства на нормальное физическое и психическое здоровье людей»[8].

В.С. Егоров считает, что «преступления против здоровья населения – это запрещенные уголовным законом деяния, связанные с незаконным оборотом опасных для здоровья веществ и препаратов, несоблюдением санитарно-эпидемиологических правил либо с иными нарушениями, опасными для общественного здоровья»[9].

И.Ю. Белый предлагает следующее определение: «Под преступлениями против здоровья населения понимаются виновно совершенные общественно опасные деяния (действия и бездействия), посягающие на безопасность здоровья населения, причиняющие им существенный вред или создающие угрозу его причинения, предусмотренные главой 25 УК РФ и запрещенные ею под угрозой наказания» [10].

А.И. Чучаев полагает, что «преступления против здоровья населения – это предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, выражающиеся в нарушении установленных в Российской Федерации правовых норм, обеспечивающих здоровье неопределенного круга лиц, и

причиняющие им существенный вред или создающие угрозу его причинения»[11].

По нашему мнению, преступления против здоровья населения – это виновно совершенные общественно опасные деяния, направленные на подрыв целостной системы, обеспечивающей физическое и психическое благополучие людей, создающие угрозу продолжительности активной жизни и ее воспроизводства в обществе, нарушающие оптимальные условия труда и отдыха, препятствующие формированию и развитию личности, запрещенные уголовным кодексом под угрозой наказания.

Признавая высшей ценностью человека, приоритет его прав и свобод, государство обязано, в том числе и уголовно-правовыми средствами, обеспечить соблюдение гражданами правил, направленных на поддержание безопасности здоровья населения, духовных и моральных устоев общества. Преступления против здоровья населения негативно влияют на процесс формирования и развития личности, на регулирование общественных связей в семье и коллективах, укрепление демократического, правового государства.

Специфическая особенность данных преступлений заключается в том, что их совершение влечет причинение вреда здоровью не отдельного человека (персонифицированной личности), а многих лиц, составляющих население всей страны или отдельного ее региона (т.е. неопределенного круга лиц).

Уголовно-правовая охрана здоровья осуществляется нормами различных разделов и глав Особенной части УК РФ – о преступлениях против личности (гл. 16 УК), общественной безопасности (гл. 24 УК), экологических преступлениях (гл. 26 УК) и др. Однако задачей этих норм является обеспечение неприкосновенности здоровья отдельной личности. В отличие от соответствующих посягательств, преступления против здоровья населения подрывают здоровье многих лиц или части населения в определенной местности. Поэтому особенностью данной группы преступлений (гл. 25 УК) является неопределенно широкий круг возможных потерпевших. Специфика объекта охраны, предметов преступного посягательства, особенностей орудий и средств преступления, способы его совершения позволяют объединить вышеуказанные нормы в одну группу, а здоровье населения рассматривать как самостоятельную ценность, нуждающуюся в комплексной уголовно-правовой защите [12].

Действующий Уголовный кодекс РФ к преступлениям против здоровья населения относит 14 самостоятельных составов (ст. 228-239). В научной и учебной литературе по-разному подходят к вопросам классификации преступлений против здоровья населения.

Так, Р.Р. Галиакбаров предлагает данную группу преступлений классифицировать следующим образом:

1) общие виды преступлений против здоровья населения. К их числу он относит: а) незаконное занятие частной медицинской практикой и частной фармацевтической деятельностью (ст. 235); б) нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236); в) сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей (ст. 237); производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238);

2) преступления, сопряженные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 228-234);

3) преступления, связанные с причинением вреда здоровью граждан, с побуждением их к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению иных противоправных деяний по религиозным и иным мотивам (ст. 239) [13].

С точки зрения образовательного (познавательного) процесса наиболее распространенной является следующая классификация:

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и нарушением правил

их легального обращения (ст. 228-233 УК РФ).

2. Преступления, связанные с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ и нарушением правил их легального обращения (ст. 234 УК РФ).

3. Преступления, нарушающие нормальную частную медицинскую, фармацевтическую деятельность и санитарно-эпидемиологические правила (ст. 235-236 УК РФ).

4. Иные преступления против здоровья населения (ст. 237-239 УК РФ).

С принятием УК России в гл. 25 неоднократно вносились изменения и дополнения. Вместе с тем эффективность многих уголовно-правовых норм недостаточно высока. Одной из причин такого положения является недостаточный учет и проработка ряда проблем в области противодействия преступлениям данной направленности. Хочется остановиться на некоторых из них. Так, возраст уголовной ответственности за совершение наркопреступлений (ст.ст. 228-233 УК РФ) законодателем установлен с шестнадцати лет. Исключение составляет только ст. 229 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ).

По результатам социологических исследований, в настоящее время средний возраст приобщения к наркотикам составляет 14-14,5 лет [14]. В данном случае получается парадоксальная ситуация, которая заключается в том, что при хищении наркотического средства лицо в 14 лет осознает общественную опасность преступного деяния, а при незаконном приобретении или хранении этого же вещества осознает только с 16 лет. Поэтому в данном случае стоит не согласиться с законодательным определением возраста уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ, так как практика показывает, что наркомания «молодеет» и осознание того, что именно этот предмет является наркотическим средством или психотропным веществом, наступает гораздо раньше 16 лет. Поэтому представляется целесообразным снижение возраста уголовной ответственности за действия, предусмотренные ст. 228 УК РФ, до четырнадцати лет. В этой связи необходимо внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ.

Необходимо использовать институт преюдиции при привлечении виновных к ответственности за совершение противоправных поступков в сфере охраны здоровья населения. Процесс преюдиции в переводе с латыни «praejudicialis» означает «относящийся к предыдущему судебному решению» или «рассмотрение на основании предыдущего решения». *По примеру ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним на территории РФ.* Виновного вначале привлекают к административной ответственности, при совершении в течение года более двух подобных правонарушений он подлежит уголовному наказанию. По нашему мнению, такая практика возможна при вынесении решений за правонарушения, предусмотренные ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). В случае совершения такого поступка впервые виновному назначается административный штраф, при повторе он будет подвергнут административному аресту, при третьем нарушении законодательства в течение года он подлежит уголовной ответственности (наказания, как правило, не будут связаны с лишением свободы).

Приоритетным направлением остается деятельность, непосредственно связанная с ресоциализацией (адаптацией) лиц, страдающих наркозависимостью. При этом важно, чтобы помощь заинтересованных органов и должностных лиц по лечению, реабилитации, трудоустройству таких лиц, была оказана своевременно и на должном уровне. Учитывая, что в настоящее время все формы принудительного лечения наркологических больных упразднены, требуются разработка и реализация новых концептуальных мер, направленных на решение данной проблемы. Необходимо предусмотреть на законодательном уровне

процедуру принудительной госпитализации и последующего лечения наркозависимых.

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ представляет не менее значимую опасность для здоровья населения страны. Государство жестко регламентирует правила обращения с этими веществами в любых сферах их применения (медицина, наука, пищевая промышленность и др.), с тем чтобы исключить любую возможность их недозволенного использования. В целях оптимизации уголовно-правовой борьбы с этими преступлениями в УК РФ предлагается предусмотреть два самостоятельных состава: «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ» (ст. 234); «Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ» (ст. 234^1). Данное разграничение позволило бы более правильно ориентироваться в вопросах квалификации преступных деяний и назначения наказания.

Реформирование экономики и социального обеспечения граждан не обошло стороной и сферу медицинского обслуживания населения, способствовало расширению в последние годы теневой медицины и фармацевтики: незаконно практикующие врачи, организации, нелегально оказывающие медицинские услуги, «знахари», «целители» и т.п. часто не только не имеют надлежащего медицинского образования, но и оказывают услуги, прямо противоречащие научным основам медицины и фармакологии, нередко ухудшающие здоровье больных и лишающие их шанса на излечение средствами и методами современной медицины[15].

Самовольное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, а равно народным целительством, как правило, связано с лишением права человека на квалифицированную медицинскую помощь и, вследствие этого, ставит под угрозу жизнь и здоровье человека. Нередко такая деятельность сопряжена с распространением непрофессиональных (шарлатанских) способов оказания медицинской помощи.

Статья 235 УК РФ предусматривает ответственность за занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. К сожалению, в данной статье ничего не говорится о противоправном занятии народной медициной (целительством), что само по себе не является равнозначным понятием частной медицинской практики. В связи с чем законодатель должен устранить этот пробел.

Одними лишь изменениями норм уголовного или административного законодательства повлиять на данную проблему невозможно. Вопросами охраны здоровья населения занимаются различные органы государственного и местного управления, в связи с чем охрана здоровья населения представляет собой деятельность медицинских, санитарно-эпидемиологических, правоохранительных, иных органов, учреждений и организаций, цель которых – сохранение физического и психического здоровья человека, предоставление своевременной, профессиональной, квалифицированной медицинской помощи, незамедлительная реакция уполномоченных органов на нарушения в данной сфере, профилактика и укрепление общественного здоровья.

Качественные сдвиги в рассматриваемой сфере возможны только при последовательном, системном, научном подходе, сочетающем в себе наработки теории и практики, активную деятельность специалистов различных отраслей и областей общественной жизни

.

ЛИТЕРАТУРА

1. См.: Тузиков А.Р. Государственное проектирование общественного здоровья сквозь призму социологии: монография. Казань: КГТУ, 2009. С. 7.

2. См.: Абызов К.Р., Гриб В.Г., Ильин И.С. Криминология: курс лекций. М.: Маркет ДС, 2010. С. 332.

3. См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.Т. Томина, В.С. Устимова, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2002. С. 676.

4. См.: Агафонов А.В. Уголовная ответственность за хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск: СЮИ МВД РФ, 2001. С. 3.

5. См.: Карасев М.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с объединениями, посягающими на личность и права граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2001. С. 4.

6. Популярная медицинская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 220.

7. Шалагин А.Е. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: учебное пособие / под ред. Ф.Р. Сундурова, Н.Х. Сафиуллина. М.: ЦОКР МВД России, 2007. С. 48.

8. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 485.

9. Егоров В.С. Уголовное право. Особенная часть: цикл лекций: учебно-методическое пособие. М.: МПСИ, 2001. С. 187.

10. Уголовное право. Особенная часть: учебник-практикум / под ред. А.С. Михлина. М.: Юристъ, 2004. С. 248.

11. Уголовное право РФ. Особенная часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2004. С. 399.

12. См.: Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 4. С. 347-348.

13. См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 484.

14. См.: Романова Л.И. Наркотизм и наркомания: монография. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 262-264; Хисамутдинов Ф.Р. Наркотизм в подростково-молодежной среде Республики Татарстан: криминологический анализ и социально-правовые меры предупреждения: монография. Казань, 2003. С. 18; Комлев Ю.Ю. Социологический мониторинг наркотизации подросткого-молодежной среды. Казань: Новое знание, 2005. С. 54-55.

15. См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.Т. Томина, В.С. Устимова, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2002. С. 672.